SDD 276 - Sujet n°1

Spécialité : Gériatrie

Date : 30/10/24
Auteur : Hélène RUBIN (DES Néphrologie, EDN 2024)
Relecteur(s) : Eloïse FRANCQ (DES Gériatrie, ECN 2020), Clément FILLIOL (DES Radiologie, ECN 2022)

Domaine d'apprentissage principal	Communication interprofessionnelle
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie pertinente de prise en charge
Item(s) en lien avec la station	120 - Complications de l'immobilité et du décubitus. Prévention et prise en charge
Situation(s) de départ en lien avec la station	276 - Prise en charge d'un patient en décubitus prolongé
Matériel nécessaire à la station	Table, chaises
Contexte de la station	L'interne de pneumologie vous contacte pour un avis concernant le risque d'escarre de son patient, Mr Oscar LEGRAND, 89 ans.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ECOS TACFA

INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :

Vous êtes interne en gériatrie dans un CHU, et vous avez été contacté par l'interne de pneumologie pour un avis concernant M. Oscar LEGRAND âgé de 89 ans.

Celui-ci est hospitalisé depuis 48h pour le traitement d'une pneumonie aiguë communautaire en cours d'amélioration clinique. L'interne de pneumologie vous appelle car le patient a déjà eu une escarre lors d'une hospitalisation antérieure, et souhaite éviter une récidive.

Consignes :

Vous devez :

- Interroger l'interne de pneumologie sur les facteurs de risque du patient de développer une escarre
- Donner des conseils de prévention des escarres adaptés à ce patient

Vous ne devez pas :

- Réaliser un examen clinique ou parler à un patient fictif (station avec PSS)
- Rédiger une ordonnance
- Prendre en charge les autres complications du décubitus
- Prendre en charge la pneumonie aiguë

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec PSS.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales

Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.

Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques			
1.	Se renseigne sur les antécédents personnels pouvant réduire la sensibilité ET la motricité du patient	1 pt	☐
2.	Se renseigne sur la présence d'une incontinence urinaire ET fécale	1 pt	☐
3.	Se renseigne sur les antécédents vasculaires du patient : AOMI, diabète, ulcère artériel…	1 pt	☐
4.	Évalue la situation nutritionnelle du patient : 2 parmi les 3 : - se renseigne sur l'IMC - recherche une éventuelle perte de poids - se renseigne sur la prise alimentaire du patient	1 pt	☐
5.	Se renseigne sur la présence de lésions cutanées préexistantes (au moins 1 parmi : cicatrice, brûlure, plaie, infection cutanée…)	1 pt	☐
6.	Se renseigne sur l'installation du patient : temps passé au lit OU capacité à se mettre au fauteuil OU présence d'éléments traumatisants.	1 pt	☐
7.	Préconise une surveillance cutanée pluriquotidienne	1 pt	☐
8.	Propose un changement de position du patient planifié plusieurs fois par jour	1 pt	☐
9.	Préconise une hygiène cutanée pour éviter la macération	1 pt	☐
10.	Prévient qu'il faut éviter les frottements et les cisaillements lors de soins : au moins 1 parmi : - privilégier le tamponnement au cours des soins d'hygiène, - soulever le patient plutôt que de le tracter, - éviter les positions semi-assises prolongées	1 pt	☐
11.	Propose un support adapté au patient à type de surmatelas dynamique, car le patient a un antécédent d'escarre et/ou passe plus de 15h par jour au lit	1 pt	☐

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

Communications et attitudes

12.

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

13.

6. COMMUNICATION AVEC LES PAIRS (clarté de communication)

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de communiquer le message	Est capable de communiquer les principaux messages, n'arrive pas à les justifier	Est capable de communiquer les principaux messages et justifier son raisonnement	Communique les informations pertinentes et les justifie. Ne s'attarde pas à de l'information inutile	Relie les informations provenant des domaines différents faisant preuve d'une maîtrise du sujet

14.

7. APTITUDE À COOPÉRER avec les pairs

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Autoritaire / Difficulté à coopérer	Communique. Transmet l'information	Communique. Adopte la technique de reformulation.	Communique les renseignements pertinents. Reconnaît les obstacles à la communication. Délègue les responsabilités en respectant les autres.	Reconnaît les problèmes de communication et sait les régler avec adresse.

15.

12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

TOTAL	15 points

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ECOS TACFA

SCÉNARIO POUR LE PROFESSIONNEL DE SANTÉ

Consignes génériques pour le PSS :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, ne pas improviser et répondre « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario (contexte de la station) :

Le candidat joue le rôle d'un ou une interne en gériatrie.
Vous êtes un ou une interne en pneumologie, et vous vous occupez de Mr Oscar LEGRAND, patient de 89 ans, hospitalisé depuis 48h en salle pour la prise en charge d'une pneumonie aiguë communautaire non grave, en amélioration clinique actuellement.

Vous avez vu dans le dossier que le patient a déjà présenté une escarre lors d'une précédente hospitalisation, et vous souhaitez vous informer sur la prise en charge d'un patient en décubitus prolongé.

Plan de la station ECOS :

PSS et candidat assis face à face.

Phrase de démarrage du PSS :

"Bonjour ! Alors j'ai quelques questions concernant mon patient, Mr LEGRAND qui a 89 ans. J'ai peur qu'il fasse une nouvelle escarre pendant son hospitalisation dans notre service."

Identité du patient :

Monsieur Oscar LEGRAND, 89 ans.
Poids : 70 kg (stable)
Taille : 1,72 m
IMC : 23,6 kg/m²

Constantes :

T° : 37,9°C
Fc : 85 bpm PA : 145/78 mmHg
FR : 22 /min SpO2 : 97 % en air ambiant

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

Mode de vie du patient :

Retraité, ancien chauffagiste chez EDF.
Marié, 3 enfants de 53, 51 et 46 ans. Viennent fréquemment lui rendre visite.

En EHPAD.
Dépendant pour l'hygiène corporelle, l'habillage et la locomotion, ne peut pas aller aux toilettes seul. Incontinences urinaires occasionnelles, pas d'incontinence fécale.
Se sert et mange seul.

Compose quelques numéros pré-enregistrés sur son téléphone ; ne se déplace jamais seul ; prend ses médicaments avec la présence de l'IDE de l'EHPAD ; pas de gestion de son budget.

Tabagisme sevré il y a 3 ans, estimé à 45 PA
Pas de consommation d'alcool ni d'autres toxiques.

Comportement global du PSS :

Interne connaissant bien le dossier du patient mais pas à l'aise pour la prise en charge des complications du décubitus. Soucieux d'éviter une récidive d'escarre chez son patient.

Antécédents personnels du patient :

Sclérose en plaques diagnostiquée à 40 ans, de forme primaire progressive.

- Hypoesthésie sensitive bilatérale des membres inférieurs (déficit de sensibilité tactile et proprioceptive).
- Déficit moteur à 2/5 pour tous les groupes musculaires des membres inférieurs de manière bilatérale.
- Fatigue chronique.
- Hyperactivité vésicale et fuites urinaires
- Pas d'incontinence fécale.
- Pas d'autres complications (pas d'atteinte du tronc cérébral, pas de trouble de déglutition, pas de douleur neuropathique, pas d'atteinte ophtalmologique).

Hypertension artérielle équilibrée sous bithérapie depuis l'âge de 55 ans.

Syndrome dépressif avec traitement antidépresseur à l'âge de 47 ans et 83 ans, arrêté il y a 3 ans.

Hospitalisation il y a 1 an pour chute et fracture du col fémoral droit, avec pose de prothèse de hanche. Complication avec escarre de stade 2 au talon droit suite à un décubitus prolongé, avec amélioration clinique dans les suites.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

Antécédents familiaux :

Mère : hypertension artérielle.
Père : cancer du poumon lié au tabac, sans autre précision
Fille de 53 ans : trouble bipolaire sous lithium.

Médicaments :

Baclofène 30 mg par jour.
Ramipril 5 mg par jour.
Amlodipine 10 mg par jour.

Lors de l'hospitalisation actuelle, en plus :
- Amoxicilline 3 g toutes les 8h.
- Lovenox 4000 UI SC 1 fois par jour.

Allergie :

Aucune.

Symptômes et signes physiques positifs :

Asthénie évoluant de manière chronique depuis la découverte de la SEP.

Déficit sensitif tactil et proprioceptif des membres inférieurs de manière bilatérale. Déficit moteur à 3/5 bilatéral des membres inférieurs.

Incontinences urinaires occasionnelles.

Trouble neurocognitif majeur avec répercussions sur l'utilisation du téléphone, dans la gestion de ses dépenses, de ses médicaments et des transports.

Immobilisation au lit > 20h par jour.

Symptômes et signes physiques négatifs :

Pas de perte d'appétit ni de perte de poids récente, non dénutri.
Pas de douleur neuropathique. Pas de douleur aux points d'appui prolongés.
Pas de trouble de conscience, Glasgow = 15.

Absence d'escarre sur l'ensemble du tégument.
Pas d'infection cutanée.

Questions de relance :

Au bout de 5 min, si le candidat <u>n'aborde pas les éléments de prévention</u> :
- "Alors, qu'est ce que je peux faire dans mon service pour éviter une récidive de l'escarre ?"

Si <u>mobilisation du patient abordée</u> par l'étudiant, demander des précisions :
- "À quelle fréquence dois-on mobiliser le patient dans le service ?"

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR

Plan de la station ECOS :

Pas de matériel particulier.
Candidat et PSS assis face à face.

Matériel nécessaire à la station :

- IPAD ou grille papier pour examinateur
- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Stylo pour évaluateur

Documents présents dans la station :

- Feuilles d'évaluation de papier de secours
- Rappel de la consigne

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)